Prise en charge interventionnelle des tumeurs osseuses malignes : le paradigme palliatif-curatif

Titre original : Interventional management of malignant bone tumours

Auteurs : Cazzato RL, Garnon J et al. | **Revue :** *Journal of medical imaging and radiation oncology* (**IF : 1.8**) | **Date :** Déc. 2023 | **PMID :** 37742284 | **Modalité :** Scanner TDM / Fluoroscopie

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Issu de votre collection Zotero « Ablation percutanée » (*J Med Imaging Radiat Oncol*, déc. 2023) — Synthèse décisionnelle structurant l'association ablation (cryo, RF, ECT) et consolidation (cimentoplastie, vissage) en oncologie osseuse.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Revue clinique (*JMIRO*, déc. 2023) structurant la radiologie interventionnelle des tumeurs osseuses malignes autour du paradigme « palliatif–curatif », articulant techniques d'ablation (cryoablation, RF, micro-ondes, électrochimiothérapie) et techniques de consolidation (cimentoplastie, ostéosynthèse percutanée).

Analyse détaillée : Cet article propose un cadre décisionnel pragmatique pour le radiologue interventionnel face aux métastases osseuses et tumeurs malignes primitives. Il distingue l'approche palliative (soulagement rapide de la douleur et prévention fracturaire par cimentoplastie/vissage +/- ablation de debulking) de l'approche curative (destruction A0 avec marges de sécurité chez le patient oligométastatique). Il compare les avantages respectifs de la cryoablation, de la radiofréquence, des micro-ondes et de l'électrochimiothérapie selon la topographie (rachis vs bassin vs os longs) et la proximité nerveuse.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Évaluation multidisciplinaire (score SINS au rachis, Mirels sur os longs, Harrington au cotyle) • Choix de la modalité ablative selon la taille et la matrice osseuse • Consolidation systématique par ciment PMMA et/ou vis canulées en zone de contrainte mécanique.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Articulation claire du paradigme « palliatif vs curatif » en radiologie interventionnelle oncologique osseuse.
- Complémentarité systématique entre destruction tumorale (cryoablation / RF / ECT) et stabilisation mécanique (cimentoplastie / vissage).
- Intégration des scores d'instabilité mécanique (SINS, Mirels) dans l'arbre décisionnel interventionnel.
- Place spécifique de l'électrochimiothérapie et de la cryoablation sous neuromonitoring pour les lésions péri-nerveuses.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

In the last few decades, interventional radiology (IR) has significantly increased its role in the management of bone tumours including bone metastases (BM) that represent the most common type of tumour involving the bone. The current IR management of BM is based on the 'palliative-curative' paradigm and relies on the use of consolidative (i.e. osteplasty, osteosynthesis) and/or ablation (i.e. cryoablation, radiofrequency ablation, electrochemotherapy) techniques. The present narrative review will overview the current role of IR for the management of BM.